

Sub-estudio · Capa 2: COVID y patología psiquiátrica

¿Aumentó la enfermedad mental, o solo el uso de camas? Quiebre de
tendencia en las hospitalizaciones por diagnóstico CIE-10 (F00-F99),
2001-2025

Análisis de Indicadores Hospitalarios · DEIS/MINSAL
Matías Durán · Data & Business Analyst

1. Por qué una segunda capa

La primera capa de este sub-estudio respondió, con datos REM20, si el COVID causó el aumento de las hospitalizaciones por salud mental —el uso de camas psiquiátricas—. Su veredicto fue claro: no; esa tendencia ya venía desde 2014 y la pandemia no la creó. Pero REM20 mide camas y flujo, no diagnóstico: no puede decir si lo que aumentó fue la patología psiquiátrica, es decir, la enfermedad.

Esta segunda capa ataca exactamente esa pregunta con una fuente distinta: los egresos hospitalarios del DEIS/MINSAL, que registran el diagnóstico principal en CIE-10. Aislado el capítulo V (F00-F99, trastornos mentales y del comportamiento) se obtiene una serie anual 2001-2025 de hospitalizaciones por diagnóstico psiquiátrico, y se le aplica el mismo criterio de quiebre de tendencia: ¿hubo un corte estructural en 2020 o la patología seguía una trayectoria previa?

Una precisión de alcance, igual de importante que en la Capa 1: un egreso con diagnóstico F mide una hospitalización por trastorno mental, no la incidencia poblacional de la enfermedad. Aun así, es un salto cualitativo respecto de REM20, porque ahora sí hay diagnóstico clínico detrás de cada caso.

2. Datos y metodología

La serie cubre 25 años (2001-2025) e integra cerca de 776.000 egresos con diagnóstico principal F00-F99, extraídos de los ~40 millones de egresos hospitalarios totales del período. La granularidad de la fuente es anual (no mensual como REM20), por lo que el análisis del quiebre es más grueso pero cubre un horizonte mucho más largo.

Se replican las tres técnicas de la Capa 1, adaptadas a datos anuales: (i) regresión segmentada de series temporales interrumpidas con errores HAC, que estima la pendiente pre-COVID, el cambio de nivel en 2020 y el cambio de pendiente posterior; (ii) un contrafactual que proyecta la tendencia previa con banda de 95%; y (iii) un grupo de control —el resto del sistema hospitalario, no psiquiátrico— para una lectura de diferencias en diferencias. Adicionalmente se desglosa el cambio por grupo diagnóstico, algo que la Capa 1 no permitía.

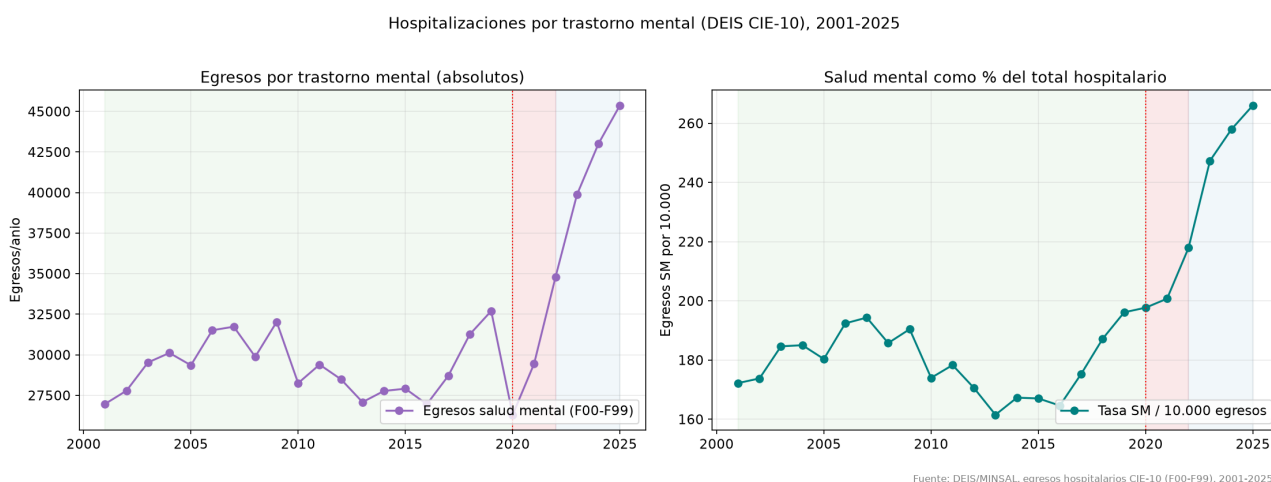
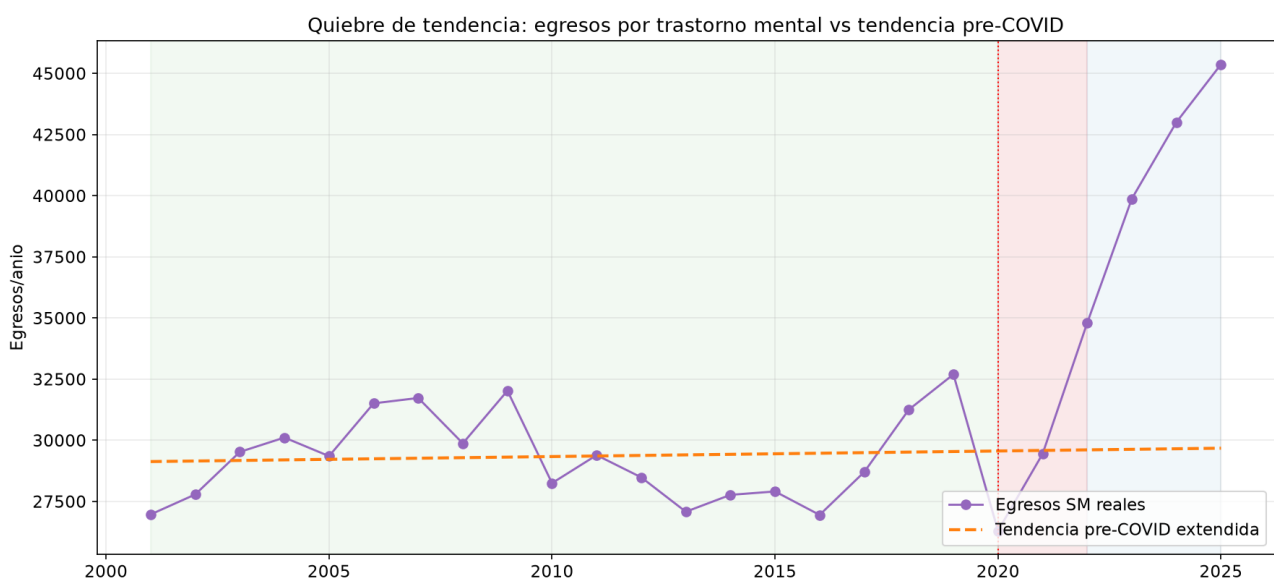


Figura 1. Egresos por trastorno mental (F00-F99), 2001-2025. A la izquierda, valores absolutos; a la derecha, su peso sobre el total hospitalario (por 10.000 egresos). Ambos estables hasta 2019 y con un quiebre al alza tras 2020.

3. Resultado: la patología estuvo plana dos décadas y se quiebra al alza tras 2020

A diferencia de las camas, las hospitalizaciones por diagnóstico psiquiátrico no mostraban una tendencia significativa antes de la pandemia: la pendiente pre-COVID (2001-2019) fue de apenas +22,8 egresos por año y no significativa ($p=0,77$). Durante casi dos décadas, los egresos con diagnóstico F oscilaron sin rumbo claro en torno a 27.000-32.000 al año.

El modelo detecta un quiebre estructural fuerte y altamente significativo coincidente con la pandemia (test F de quiebre = 211,7; $p<0,001$). Como en la Capa 1, 2020 trae primero una caída —cambio de nivel de -3.177 egresos ($p=0,014$), el colapso de la actividad hospitalaria electiva—, pero a continuación la pendiente cambia en +4.009 egresos por año ($p<0,001$): un cambio de régimen, no la continuación de una tendencia previa. En cifras crudas, los egresos por trastorno mental pasan de 32.695 en 2019 a 45.372 en 2025 (+38,8%).



Fuente: DEIS/MINSAL, egresos hospitalarios CIE-10 (F00-F99), 2001-2025

Figura 2. Egresos reales por trastorno mental frente a la tendencia pre-COVID extendida. La trayectoria previa era esencialmente plana; el alza posterior a 2020 se despega con claridad.

4. El quiebre es específico de salud mental

El contrafactual cuantifica la magnitud. Tras descontar la caída de la fase aguda —brecha media de -1.702 egresos/año en 2020-2021—, el período post-COVID (2022 en adelante) se ubica +37,5% sobre lo esperado por la tendencia previa, una brecha media de +11.119 egresos por año. Medido como peso sobre el total hospitalario, el exceso es aún mayor: +41,4% sobre lo esperado, porque el total de egresos del país no creció igual.

El grupo de control confirma que el fenómeno es diferencial de salud mental y no un movimiento general del sistema: mientras la patología psiquiátrica quedó +37,5% sobre lo esperado, el resto del sistema hospitalario quedó -3,6%. La diferencia en diferencias es de +41,1 puntos porcentuales a favor de salud mental —una brecha mucho mayor que los +9,2 pp observados en la Capa 1 con datos de camas.

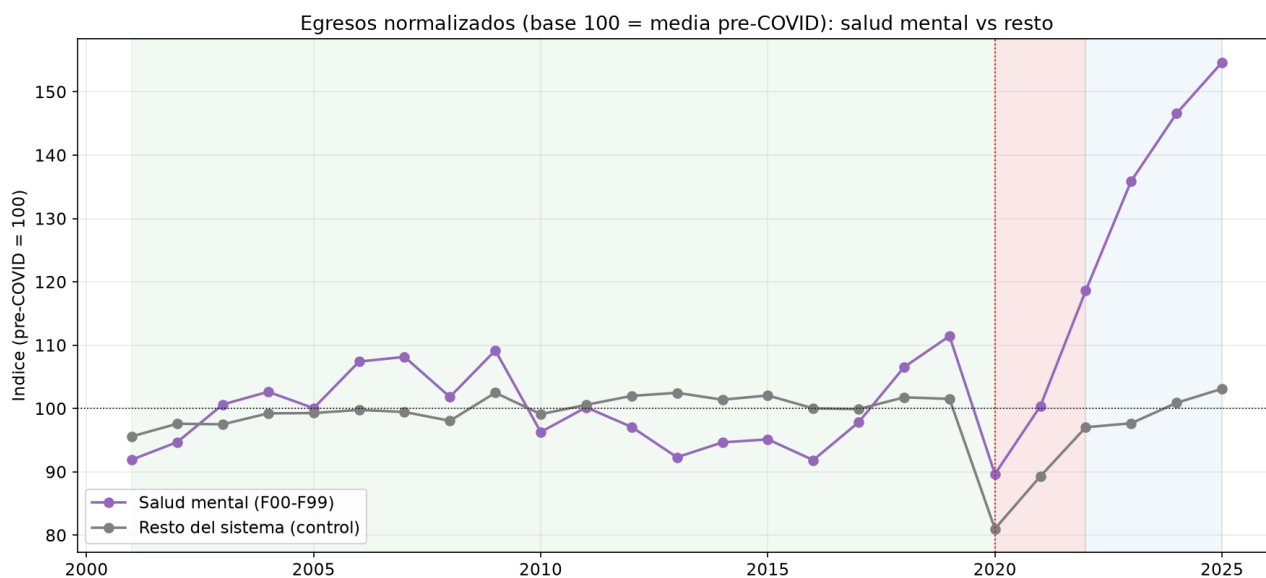


Figura 3. Egresos normalizados (base 100 = media pre-COVID): salud mental vs. resto del sistema. La divergencia tras 2020 es pronunciada y sostenida.

5. Qué patologías explican el alza

El desglose por diagnóstico —ventaja exclusiva de esta capa— muestra que el aumento no es homogéneo. En términos absolutos, el mayor motor son los trastornos afectivos (F30-F39, depresión y bipolaridad): de 8.330 egresos anuales promedio en 2015-2019 a 12.898 en 2022-2024 (+54,8%, +4.568 egresos). Les siguen los trastornos de ansiedad y estrés (F40-F48, +52,3%).

En términos relativos, los mayores crecimientos están en población joven y en cuadros del desarrollo y la personalidad: trastornos del desarrollo (F80-F89, +105,4%), de la personalidad (F60-F69, +78,0%) y de inicio en la infancia y adolescencia (F90-F99, +76,5%). En contraste, dos grupos cayeron: los trastornos por consumo de sustancias (F10-F19, -10,2%) y la discapacidad intelectual (F70-F79, -24,3%). El patrón es coherente con un aumento de la carga de depresión, ansiedad y salud mental infanto-juvenil tras la pandemia.

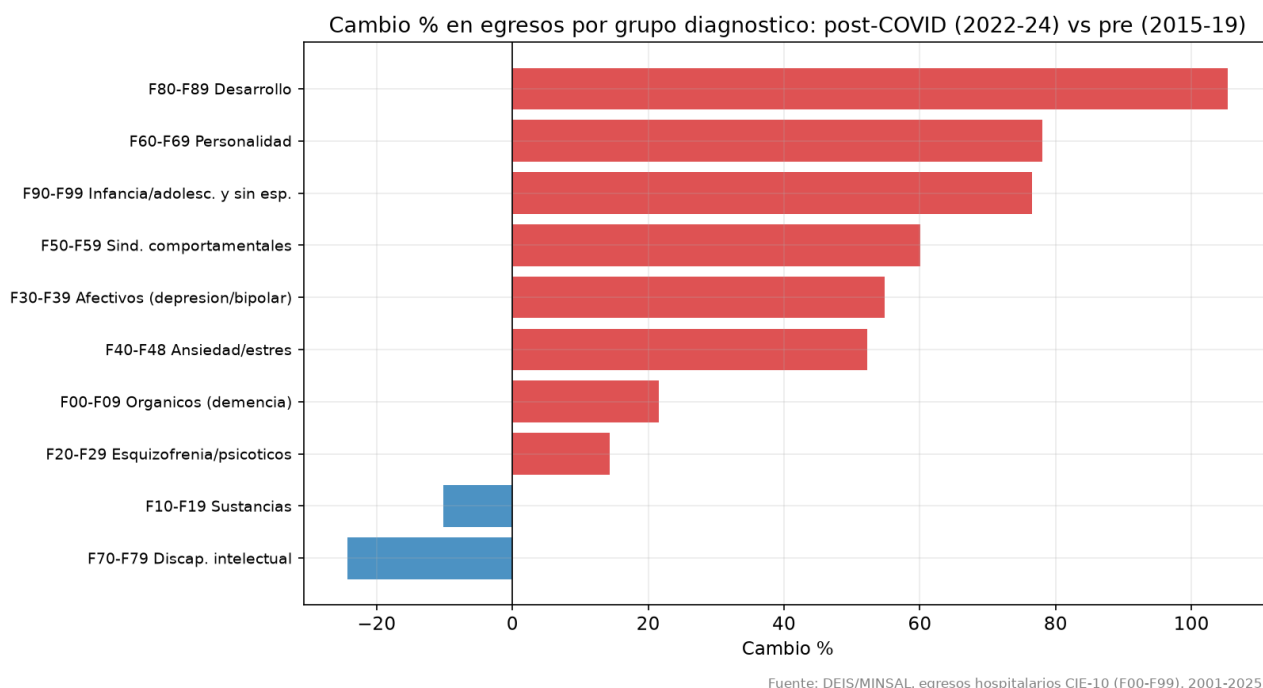


Figura 4. Cambio porcentual en egresos por grupo diagnóstico: post-COVID (2022–2024) frente a pre-COVID (2015–2019). En rojo los que aumentan; en azul los que disminuyen.

6. Síntesis de las dos capas

Las dos capas miden cosas distintas y, juntas, dan una respuesta más honesta que cualquiera por separado. Hospitalización (camas, REM20): el uso de camas psiquiátricas ya crecía desde 2014; el COVID no lo causó (Capa 1). Patología (diagnóstico, DEIS): las hospitalizaciones con diagnóstico de trastorno mental estuvieron planas durante dos décadas y se quiebran al alza justo después de 2020, de forma específica de salud mental y concentrada en depresión, ansiedad y población infanto-juvenil (Capa 2).

La reconciliación es coherente: el alza de patología se expresa más en flujo —egresos, casos atendidos, alta rotación— que en stock de camas ocupadas, tal como ya anticipaba la Capa 1. Es decir, el sistema absorbió más hospitalizaciones psiquiátricas sin una expansión equivalente de camas, probablemente vía estadías más cortas y atención en hospitales generales.

Respuesta a la pregunta original — ¿fue el COVID? Depende de qué se mida. La necesidad de camas psiquiátricas no la creó la pandemia: es una tendencia estructural previa. Pero la patología psiquiátrica hospitalizada sí muestra un quiebre fuerte, significativo y específico que coincide con el COVID y no existía antes — la señal más sólida de un cambio asociado a la pandemia que arroja todo el estudio.

7. Salvedades y honestidad del dato

El quiebre de la Capa 2 es una asociación temporal fuerte, no una prueba de causalidad. La fuente mide hospitalización por diagnóstico, no incidencia poblacional: parte del alza podría reflejar mayor búsqueda de atención, menor estigma, cambios en los criterios de codificación o de admisión, o la expansión de programas de salud mental, además de un aumento real de la enfermedad. Distinguir estos componentes exigiría datos ambulatorios (REM serie A), licencias médicas (SUSESO) o encuestas poblacionales (ENS).

Limitaciones técnicas: la serie es anual (punto de interrupción fijo en 2020, sin resolución intra-anual), el contrafactual asume continuidad lineal de la tendencia previa, y la comparación se hace sobre promedios de período. Aun con esas cautelas, la magnitud del quiebre ($F=211,7$; +37,5% sobre lo esperado; +41,1 pp frente al control) es lo bastante grande y consistente como para tratarse de un hallazgo robusto dentro de su marco: un cambio real en las hospitalizaciones por diagnóstico psiquiátrico, coincidente con la pandemia y concentrado en cuadros específicos.